

어린이 체험활동 손상예방을 위한 가이드라인



어린이 체험활동 손상예방을 위한 가이드라인 활용 안내

- 손상이란 외부의 힘에 의해 신체가 다치는 것으로 약물 중독(음식 제외)이나 벌레 쏘임, 넘어지거나 찢어지는 등의 외상, 교통사고 등을 말합니다. 본 가이드라인은 체험활동 중 발생 건수가 많거나, 입원 및 사망률이 높은 손상을 예방하기 위해 제작되었습니다(운수사고, 야외활동-환경손상·추락·낙상, 물놀이). 주요 손상 내용에 따른 응급처치 수칙과 의학적 지식을 수록하였으며, 미아 발생, 체험활동 시 발생한 질병에 대한 내용은 포함하고 있지 않습니다.
- 학령전기 어린이(4~6세), 학령기 어린이(7~13세)를 대상으로 이 가이드를 활용하여 체험활동 전에 어린이들에게 안전한 환경 조성을 위한 교육을 실시할 수 있습니다. 체크리스트를 통해 교사나 인솔자가 체험활동 전 안전 대책을 점검하고, 가이드라인을 통해 예방 수칙 및 응급처치 방법을 학습합니다.
 - 체크리스트 : 체험활동 전에 확인하고 대비해야 할 주요 요소를 제공
 - 가이드라인 : 인솔자를 위해 제공되는 주요 손상에 대한 예방수칙과 응급처치 관련 내용
 - 동영상 : 어린이를 대상으로 10분 내외 길이의 동영상을 통해 이동 중 손상예방과 실내/외 체험활동 손상 예방 교육용 자료



체험활동 중
교통사고



야외 및 실내
체험활동



☑ 보호자의 활용

- 가이드라인을 활용하여 체험활동 중 손상을 예방할 수 있는 방법과 응급조치를 이해합니다.
- 동영상을 활용하여 어린이들에게 손상예방의 중요성과 안전한 행동 습관을 익히도록 합니다.



☑ 교사 및 인솔자의 활용

- 가이드라인을 활용하여 체험활동 중 손상을 예방할 수 있는 방법과 응급조치를 이해합니다.
- 체크리스트를 통해 체험활동 전 사전 점검 시 활용가능합니다.



☑ 어린이 교육 활용

- 동영상 교육자료를 활용하여 손상예방을 학습의 폭을 확장할 수 있습니다.
- 손상예방에 대한 인식을 높일 수 있도록 다양한 교육 활동에 활용할 수 있습니다.

어린이 체험활동 **손상예방**을 위한 가이드라인

목 차

1. 물놀이 활동 손상 예방 및 응급처치 수칙	5
가. 활동 전 주의사항	5
1) 장소 안전 확인	5
2) 어린이의 준비	5
3) 동행 교사의 준비	5
나. 물놀이 활동 중 주의사항	6
1) 어린이 주의사항	6
2) 동행 교사 주의사항	6
다. 물놀이 안전사고	7
1) 수영장, 워터파크	7
2) 야외 물놀이 (계곡, 강, 바다 등)	7
라. 흔한 손상과 응급처치	8
1) 피부 상처(열상, 찰과상)	8
2) 머리를 부딪힘	8
3) 신체 부딪힘(머리 제외)	8
4) 쥐가 났을 때(근육경련)	8
5) 저체온증(춥고 몸이 떨릴 경우)	9
6) 해파리에 쏘였을 때(해수욕장, 바닷가)	9
마. 익수 사고	10
1) 구조법	10
2) 응급처치(심폐소생술)	10
2. 야외활동 안전사고 예방 및 응급처치 수칙	13
가. 사고 발생 시 행동 지침	13
1) 어린이 주의사항	13
2) 동행 교사 주의사항	13
나. 손상 유형별 응급처치 수칙	14
1) 염좌 또는 골절 의심	14
2) 사지 외상	14
3) 화상	14
4) 추락 손상	14
다. 기본 심폐소생술(일반인 구조자)	15

어린이 체험활동 **손상예방**을 위한 가이드라인

목 차

3. 환경손상 예방을 위한 예방 및 응급처치수칙	16
가. 온열질환	16
1) 일사병	16
2) 열사병	16
3) 온열질환 예방 방법	16
4) 온열질환 응급처치법	17
나. 음식 알레르기	18
1) 증상	18
2) 음식 알레르기 예방 방법	18
3) 음식 알레르기 응급처치법	19
다. 일반 알레르기	19
1) 어린이의 준비	19
2) 동행 교사의 준비	19
라. 벌레 물림	19
1) 흔하게 노출되는 벌레의 종류	19
2) 벌레 물림의 증상	20
3) 벌레 물림 예방 방법	20
4) 벌레에 물렸을 때 응급처치법	20
5) 벌에 쏘인 경우	20
마. 뱀물림	21
1) 동행 교사의 준비	21
4. 이동중 운수사고 예방 및 응급처치	22
가. 도보	22
1) 인도 통행 시	22
2) 횡단보도	23
나. 차량	23
1) 운행 전후	23
2) 운행 중	24
3) 사고 발생	24
다. 기차/지하철	25
1) 승강장에서	25
2) 사고 발생	26
라. 선박	27
1) 항해 전후	27
2) 항해 중	27
3) 사고 발생	27
마. 응급처치	28

1. 물놀이 활동 손상 예방 및 응급처치 수칙

가. 활동 전 주의사항

1) 장소 안전 확인

- » 물놀이를 위해 만들어진 장소인지 혹은 금지 지역은 아닌지 확인합니다.
- » 물이 너무 깊거나 수심의 변화가 심한 곳은 피합니다.
- » 물이 아주 차가운 곳은 피합니다.
- » 바위와 같은 단단한 물체에 부딪힐 수 있는 곳은 피합니다.
- » 구조대원 혹은 안전관리요원이 있는지 확인하고 지시에 따릅니다.
- » 물놀이 구역 모든 곳에서 동행한 어른이 관찰할 수 있는지 확인합니다.
- » 미끄럼틀이나 기구가 있는 경우 사전에 이용 안전 수칙을 확인하고 교육합니다.

2) 어린이의 준비

- » 수영장에서는 위생과 안전을 위해서 수영모와 수경(물안경)을 착용합니다.
- » 수상레저를 즐길 때는 반드시 구명조끼를 착용합니다.
- » 수영을 하기 전 반드시 준비운동을 합니다.
- » 물에 들어가기 전 수온을 파악하고 심장에서 먼 부분부터(다리, 팔, 얼굴, 가슴 등의 순서) 물을 적신 후 천천히 들어갑니다.
- » 건강 상태가 나쁘거나 몸이 배가 고프거나 식사 직후에는 물놀이를 하지 않습니다.
- » 질식의 위험이 있으므로 음식물이나 껌을 입에 문 채로 물놀이를 하지 않습니다.
- » 각종 동물 모양의 보행기 형태로 어린이를 태우고 양 다리를 끼우는 방식의 튜브는 뒤집혀 익사할 가능성이 있으므로 사용하지 않습니다.

3) 동행 교사의 준비

- » 가능하다면 어린이들의 사전 수영 실력을 확인합니다. (물의 깊이는 어린이의 개별 체력과 능력에 맞아야 하며 안전 장비가 필요합니다.)
- » 사고 발생 시 응급조치 및 대처요령을 교육하고 현장관리 계획을 수립합니다.
- » 환자 발생 시 신속한 환자 수송을 위한 인근 의료시설의 위치를 미리 파악하고 숙지합니다.
- » 물놀이 사고는 갑작스럽게 발생하기 때문에 빠른 상황 판단과 대처가 필요하므로 되도록 전날과 당일에 음주 또는 졸음을 유발할 수 있는 약물은 피하도록 합니다.

- 머리카락 등으로 인한 수질 오염이나 배수구 막힘을 예방하기 위해서 **수영모**를 착용하도록 합니다.
- 수영장 위생을 위해 사용한 소독약이 눈에 자극적일 수 있으므로 **물안경**을 착용하도록 합니다.
- 사전에 3분 이내의 간단한 준비운동을 만들어 옵니다. 공개 프로그램 동영상 등을 활용하거나 운동 동작 카드를 활용할 수 있습니다.
- 일반적으로 차갑다고 느끼는 온도는 30℃ 이하입니다. 수영장 물의 평균 온도는 25~29℃로 갑자기 찬물에 전신을 담그면 심혈관계에 부담이 됩니다. 따라서 심장에서 먼 손과 발 부위부터 천천히 물을 적셔서 입수하도록 합니다.

나. 물놀이 활동 중 주의사항

1) 어린이 주의사항

- » 혼자서 다니지 않고 여러 사람들과 짝지어 물에 들어갑니다.
- » 얕은 곳에서 수영합니다. 얕은 물에서도 방심하지 않습니다.
- » 자신의 수영 실력이나 튜브, 구명조끼 등을 믿고 무리하면 절대 안됩니다.
- » 물에 빠진 척 허우적거리거나 '살려달라'고 장난치지 않습니다.
- » 선생님의 지도없이 절대로 다이빙하지 않습니다.
- » 어른이 보이는 곳에서 수영하고 지정된 구역에서만 놀이합니다.
- » 물놀이 도중 피부에 소름이 돋고 몸이 덜덜 떨릴 때에는 즉시 물 밖으로 나와 휴식을 취하고 몸을 따뜻하게 합니다.
- » 배 혹은 물 위에 떠 있는 큰 물체 밑을 헤엄쳐 나가는 것은 물체 바닥에서 빠져나오지 못할 수 있어 위험하므로 하지 않습니다.
- » 수영할 줄 모른다면 반드시 보호자와 동행해야 합니다.
- » 휴식없이 장시간 계속 수영하지 않습니다.
- » 식사 후 최소 1시간 30분이 지난 후에 활동해야 합니다.
- » 사고가 발생하면 빨리 주변에 알립니다.

2) 동행 교사 주의사항

- » 어린이는 순간적으로 물에 빠질 수 있으므로 항상 주시해야 합니다.
- » 얕은 물에서도 물놀이 사고는 방심해서는 안됩니다.
- » 활동 구역을 정하고 어린이들이 정해진 구역에서만 움직이도록 해야합니다
- » 인지, 신체 능력이 떨어지는 유아나 어린이들은 보호자의 손을 뻗어 즉각 구조가 가능한 위치에서 감독해야 합니다.
- » 만 6~9세 이하 어린이들은 보호자의 통제권을 벗어나려는 경향을 보이므로 사전 안전 교육 및 주의를 여러 차례 주어 통제합니다.
- » 물놀이 중 수시로 인원 점검 및 개인 행동 여부를 관리하고 안전사고가 있었는지 확인합니다.
- » 기상 상태를 수시로 확인하며 소나기, 번개, 천둥, 심한 안개 시에는 물놀이 활동을 중단하고 신속하게 안전한 곳으로 대피시킵니다.
- » 야외 수상 활동의 경우 일몰 후 30분, 일출 전 30분까지는 활동을 금지합니다.

- 물놀이는 에너지 소비와 피로도가 높으며 물 속에서 발생한 사고는 익수, 심정지 등 심각한 손상으로 바로 이어짐으로 무리한 활동은 금해야 합니다.
- 물에 빠진 척하는 장난은 실제 응급 상황에서도 주위의 사람들이 장난으로 오인하여 심각한 사고로 이어질 수 있습니다.
- 수온이 낮거나, 젖은 상태로 시간이 오래 지나면 저체온이 발생할 위험이 있습니다. 저체온이 의심되는 경우 수건 등으로 몸의 물기를 닦아주고, 마른 수건으로 몸을 감싸주는 방법으로도 쉽게 예방할 수 있습니다.

- 인솔자가 휴식 시간을 미리 지정합니다. (30분 혹은 40분 활동 후 10분 휴식 등)

다. 물놀이 안전사고

1) 수영장, 워터파크

- » 수영장, 워터파크 사고는 수영장이나 화장실 바닥, 계단 등에서 미끄러지고 넘어지거나 워터슬라이드에 부딪히는 사고가 대다수를 차지하고 있고 깨진 타일에 베이거나, 배수구에 팔이나 발이 끼이는 사고도 발생합니다. 이때에는 큰 소리로 인근의 보호자 등 다른 사람에게 알려야 합니다.
- » 부상별로는 피부 및 피하조직 손상, 근골격계(근육, 뼈, 인대 손상), 뇌진탕, 타박상 등의 순으로 손상이 발생하고 있습니다.
- » 물 안에서의 활동은 육지와는 완전히 다른 환경입니다.
- » 어디서든 물이 있는 곳에서는 수상 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- » 특히 어린이와 관련 안전사고는 어른들의 부주의와 감독 부족으로 인해 발생할 수 있습니다.
- » 인지 능력과 신체 적응력이 부족한 유아와 어린이들은 보호자가 근처에서 즉각적으로 구조할 수 있는 위치에서 감독이 되어야 합니다.
- » 만 6~9세 이하 어린이들은 활동 반경이 확장되면서 보호자의 감독을 벗어나려는 경향이 있으므로 사전 안전 교육과 주의가 필요합니다.

2) 야외 물놀이 (계곡, 강, 바다 등)

가) 수초에 감겼을 때

- » 부드럽게 서서히 팔과 다리를 움직여 풀어야 합니다.
- » 물 흐름이 있으면 흐름에 맡기고 잠깐 기다리면 감긴 수초가 헐겁게 되므로 이때 털어 버리듯이 풀고 물 밖으로 나옵니다.
- » 놀라서 발버둥 치면 오히려 더 휘감겨서 위험에 빠질 수 있으므로 침착하게 여유를 가지고 호흡하며 서서히 부드럽게 몸을 수직으로 움직이면서 꾸준히 헤어 나오도록 합니다.

나) 파도에 휩쓸릴 때

- » 해안으로 밀려오던 파도가 갑자기 먼 바다 쪽으로 빠르게 되돌아가는 해류인 이안류를 특히 조심해야 합니다.
- » 당황하거나 피하려고 몸부림치지 말고 조류를 따라서 비스듬히 해변을 향해 헤엄쳐야 합니다.

다) 옷을 입은 채로 갑자기 깊은 물에 빠졌을 때

- » 큰소리를 쳐서 인근의 보호자 등 다른 사람에게 알려야 합니다.
- » 흐르는 물에 빠졌을 때는 물의 흐름에 따라 표류하며 비스듬히 헤엄쳐 나옵니다.
- » 옷이나 신발을 착용한 채로 갑자기 물에 빠졌을 때, 옷 등이 헤엄치기에 방해가 되는 경우에는 심호흡을 한 후 물속에서 새우등 뜨기 자세를 취한 다음 침착하게 벗기 쉬운 것부터 차례로 벗고 헤엄쳐 나옵니다.

- 해수욕장, 바닷가 등에서 물 속에서 시행할 응급처치는 입수 전에 미리 교육해야 합니다.



새우등뜨기

라. 혼한 손상과 응급처치

1) 피부 상처(열상, 찰과상)

- » 열상, 찰과상이 생겼을 때, 깨끗한 거즈나 천으로 상처 부위를 직접 압박하여 지혈합니다.
- » 흐르는 물에 상처를 씻어내고 상처 부위는 절대 만지지 않습니다.
- » 상처봉합은 상처가 난 후 24시간 이내에 진행해야 흉터 치료 등에 도움이 됩니다.

2) 머리를 부딪힘

- » 호흡유지, 순환여부, 의식상태 확인이 가장 우선시 되어야 합니다.
- » 머리, 경추, 척추를 함부로 움직이지 않아야 합니다.
- » 의식이 없는 경우, 최단 시간 안에 병원으로 이송해야 합니다.
- » 의식이 있는 경우, 충격 부위에 얼음 주머니 등을 이용하여 냉찜질을 시행하여 통증 경감을 시도할 수 있습니다.

3) 신체 부딪힘(머리 제외)

- » 미끄러져 발목이나 손목 골절을 당하는 경우도 많습니다.
- » 통증 부위를 가볍게 눌렀을 때 통증이 심하게 느껴지고, 점점 부어오르면 골절이 의심되는 상황입니다.
- » 억지로 뼈를 맞추려 하지 말고, 골절 부위를 부목이나 나뭇가지 등 단단한 물건으로 고정하는 것이 좋습니다.
- » 골절 직후에는 냉찜질이 도움이 됩니다.

4) 쥐가 났을 때(근육경련)

- » 탈수, 근육의 피로, 불충분한 운동 등에 의해 유발되며, 주로 종아리, 허벅지, 발 등의 다리 근육에 발생합니다.
 - » 수영 중에 갑자기 발생한 근육경련의 경우, 가능하다면 물 밖으로 나와서 경직된 근육을 문지르거나 주물러서 풀어주도록 합니다.
 - » 물 밖으로 바로 나오는 것이 불가능하다면 가장 중요한 것은 근육을 펴는 일입니다. 이때 당황해서 몸을 함부로 움직이면 도리어 익사 위험이 있습니다. 다음의 주의사항을 평상시에 숙지해 두고 물놀이 중에 근육 경련이 났을 때 활용하도록 합니다.
- ① 먼저 몸을 둥글게 모으고 물 위에 뜨도록 합니다.
 - ② 다음에는 크게 숨을 들이마시고 물속에 얼굴을 넣은 채 쥐가 난 쪽의 엄지발가락을 힘껏 앞으로 꺾어서 잡아당긴다. 한동안 계속하여 격통이 가라앉기를 기다립니다.

- 근골격계 손상 직후에는 부종을 예방하고 통증을 줄이기 위해서 스프레이나 얼음 주머니 등으로 냉찜질을 하는 것이 도움이 됩니다.

- 머리, 경추를 움직이는 경우 척수 손상이 악화되고 2차 손상이 발생할 수 있습니다.

- 근육을 신장시키는 방향, 늘려주는 방향으로 힘을 적용하여야 근육경련이 풀리게 됩니다. 예를 들어, 종아리나 발바닥 경련의 경우 발끝을 발등 쪽으로 젖히도록 당겨줍니다.

- ③ 한번 쥐가 난 곳은 다시 쥐가 날 가능성이 있으므로 통증이 사라지면 그곳을 잘 마사지하면서 천천히 욕지로 향합니다.
- ④ 욕지에 오른 다음에도 발을 뺀어 장딴지의 근육을 충분히 마사지해 줍니다.
- ⑤ 더운물이 있으면 수건에 적셔서 장딴지에 감고 온찜질을 하는 것이 효과적입니다.

5) 저체온증(춥고 몸이 떨릴 경우)

- » 가벼운 저체온증에서는 일반적으로 떨림 현상이 두드러지고, 피부에 닭살이 돋으며, 피부혈관이 수축하여 피부가 창백해지고 입술이 퍼렇게 변합니다.
- » 젖은 옷을 벗긴 후에 몸에 있는 물기를 닦은 다음, 깨끗한 수건, 옷 가지 등으로 몸을 감싸 체온이 떨어지는 것을 막아야 합니다.
- » 의식의 소실이 동반되면 중등도 이상의 저체온증일 가능성이 높으므로 즉시 119에 신고하여 병원을 방문하고 적절한 치료를 받아야 합니다.
- » 따뜻한 물이나 핫팩 등을 손발에 가져다 대지 않습니다.
- » 의식이 없는 상태라면 물 등 음식물을 섭취하게 해서는 안 됩니다.

6) 해파리에 쏘였을 때(해수욕장, 바닷가)

- » 드물게 심한 전신반응으로 혈압이 저하되거나 의식을 잃을 수 있으므로 즉시 물 밖으로 나옵니다.
- » 해파리에 쏘인 부위는 만지지 말고 바닷물을 이용해 10분 이상 씻어 줍니다.
- » 세척 후 해파리 촉수가 피부에 남아있는 경우에는 플라스틱 카드를 이용하여 제거해야 합니다.
- » 응급처치를 시행한 후에도 해파리에 쏘인 부위에 통증이 지속되고 오심, 구토, 식은땀, 어지럼증 등의 증상이 나타나면 맹독성 해파리일 가능성이 높으므로 즉시 병원을 방문하여야 합니다.

- 저체온증은 중심체온(심부체온)이 35℃ 이하로 떨어진 상태를 말하며 초기 증상은 피부 혈관이 수축하여 창백해지고 입술이 청색을 띠게 됩니다. 중등도의 저체온증(29~32℃)에서는 심장 박동이 느려지고 혈액 순환과 호흡, 신경계의 기능이 둔화되어 의식의 혼미해지고 28℃ 이하의 중증의 저체온증에서는 치명적인 부정맥에 의한 심정지가 발생할 수도 있습니다.
- 손발에 정체되어 있던 차가운 혈액을 다시 심장으로 보내 결과적으로 중심 체온을 더 떨어뜨릴 수 있습니다.
- 의식이 없는 상태에서 입안에 물 등을 넣어 주면 기도 및 폐로 흡인되어 기도 폐쇄나 호흡곤란 등을 일으킬 수 있습니다.

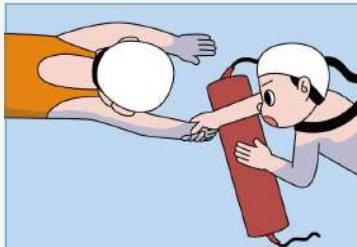


- 벌침을 제거하는 방식과 비슷하게 플라스틱 카드의 모서리를 사용합니다.

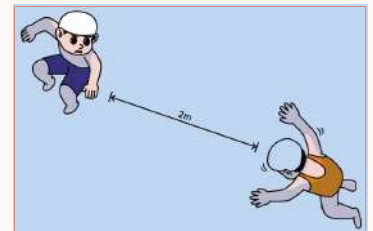
마. 익수 사고

1) 구조법

- » 주위에 소리쳐 알려서 도움을 청하되, 구조하려고 직접 물속에 뛰어들지 않습니다.
 - » 안전 장비(구명로프, 구명환, 구명조끼 등) 혹은 물에 뜨는 물건을 던져줍니다.
 - » 다른 사람이 없을 때에는 안전 장비(구명로프, 구명환, 구명조끼 등)를 이용하여 안전하게 구조합니다.
- ① 의식이 있으면 반드시 뒤쪽에서 접근합니다.
 - 머리를 팔로 끌어안듯이 하고 해엄쳐 구조합니다.
 - ② 의식이 없는 경우, 앞 다가가기 가능합니다.
 - 얼굴이 물 아래쪽을 향하고 있을 때는 구조대상자를 회전시켜 얼굴이 위로 향하도록 해줍니다.
(구조대상자를 1미터 이상 끌다가 잡고 있는 손을 물 밑으로 큰 반원을 그리듯 하며 돌려 대상자의 얼굴이 위로 나오도록 합니다.)
 - 손목 끌기는 앞 다가가기 이후에 주로 사용됩니다.
(준비서기를 유지하며 구조원의 오른(왼)손으로 구조대상자의 오른(왼) 손목을 잡습니다.)



- 발견자는 직접 구조하려고 물에 뛰어드는 것이 아니라 관리소(자) 또는 인근 소방서(119), 해양수상구조대(122)에 신속히 신고합니다.
- 실제 물에 빠진 사람을 구조하는 것은 구조대원이나 경험이 많은 전문가가 수행하도록 합니다.
- 의식이 있는 익수자(물에 빠진 사람)는 공황상태에 빠져 주변 상황에 대해 적절히 인식할 수 없고 또 구조자가 다가와 손에 잡히면 무조건 아래로 잡아당기려는 본능적인 반응을 보이기 쉽기 때문입니다. 따라서 구조자는 되도록 허우적거리는 익수자를 통제할 수 있는 뒤쪽에서 서서히 접근해야 합니다.
- 준비서기는 구조대상자의 의식을 확인하면서 구조대상자에게 잡히는 경우를 피하고, 위급상황시 언제든지 멀어질 수 있도록 대비하여, 어떤 구조기술을 사용할지 결정하는 시간입니다



2) 응급처치(심폐소생술)

- » 물에 빠진 사람을 구했는데 호흡과 맥박이 없다면 심폐소생술을 해야 합니다.
- » 머리와 목뼈에 심각한 손상이 있을 가능성이 높을 때에는 2차 손상을 예방하기 위해서 머리와 목이 위험하게 움직이지 않도록 경추보호대로 고정하면서 응급처치를 병행하도록 합니다.

- 다이빙 후 발생한 익수, 물속에 있다가 배나 암초 등에 머리를 부딪힌 경우, 혹은 자동차 사고로 물에 빠진 경우 등이 해당합니다.

가) 심폐소생술 (일반인 구조자)

- » 의식이 없다면 어깨를 흔들고 두드리며 깨워봅니다.
- » 깨워도 반응이 없는 경우 즉시 주변 사람들에게 119에 신고하고 자동 심장충격기를 가져오도록 요청한 후 119 구급상황요원의 조언에 따릅니다.
- » 환자의 호흡이 정상이라면 관찰하면서 119 구급대를 기다립니다.
- » 환자의 호흡이 없거나 비정상적이라면 심폐소생술을 시작합니다.
- » 119 도착이나 자동심장충격기 도착까지 심폐소생술을 지속합니다.

- 익수에 의한 심정지의 흔한 원인은 저산소혈증이지만, 일부 환자에게는 심장부정맥에 의해 발생하는 경우도 있으므로 필요시 자동 심장충격기(자동제세동기)를 사용할 수 있습니다.

- » 자동심장충격기를 사용할 수 있으면 음성지시에 따라서 제세동을 합니다.
- » 제세동이 필요하지 않거나 제세동을 한 직후에는 2분 동안 심폐소생술을 시행한 다음 자동심장충격기로 다시 심장 리듬을 분석합니다.
- » 119 구급대가 도착하거나 환자가 움직이거나 호흡이 정상화될 때까지 심폐소생술을 멈추지 않아야 합니다.
- » 심폐소생술은 일반인 구조자의 숙련도나 의지에 따라 가슴압박과 인공호흡을 함께 하는 표준심폐소생술을 기본으로 하되 인공호흡이 불가능하다면 가슴압박소생술만 제공하는 것도 가능합니다.

(1) 가슴압박소생술

- » 압박 위치는 양쪽 젖꼭지 부위를 잇는 선의 정중앙 바로 아랫부분(흉골의 아래쪽 1/2)입니다. 한 손으로 손바닥의 아래 부위가 환자의 흉골 부위에 접촉하도록 하고, 시행자의 어깨는 환자의 흉골이 맞닿는 부위와 수직이 되게 합니다. 양손을 포개어 겹친 뒤 깍지를 낀 상태로 손바닥 뒤꿈치를 이용하여 1분당 100~120회의 속도로 표준 깊이로 강하고 빠르게 압박합니다.
- ① 압박 위치: 젖꼭지 연결선 바로 아래 흉골(영아), 흉골 아래쪽 1/2(소아, 성인)
- ② 압박 깊이: 가슴 전후 두께의 최소 1/3 이상 압박(영아 4cm, 소아 4~5cm)
- ③ 압박 속도: 분당 100~120회

(2) 표준심폐소생술

- » 가슴압박과 인공호흡을 30:2의 비율로 반복합니다.
- » 가슴압박 30회 실시: 압박 위치는 양쪽 젖꼭지 부위를 잇는 선의 정중앙 바로 아랫부분입니다. 한 손으로 손바닥의 아래 부위가 환자의 흉골 부위에 접촉하도록 하고, 시행자의 어깨는 환자의 흉골이 맞닿는 부위와 수직이 되게 합니다. 양손을 포개어 겹친 뒤 깍지를 낀 상태로 손바닥 뒤꿈치를 이용하여 1분당 100~120회의 속도와 표준 깊이로 강하게 빠르게 30회 압박합니다.
- » 인공호흡 2회 실시: 한 손으로 환자의 턱을 들어 올리고 다른 손으로 머리를 뒤로 젖혀 기도를 개방합니다. 머리를 젖힌 손의 검지와 엄지로 코를 막은 뒤 환자의 입에 숨을 2회 불어넣습니다. 숨을 불어넣을 때 결눈질로 환자의 가슴이 상승하는지 관찰합니다.

- 효과적인 가슴압박은 심폐소생술 동안 심장과 뇌로 충분한 혈류를 전달하기 위한 필수적 요소입니다.
- 심폐소생술 교육을 받은 적이 없거나, 받았더라도 자신이 없는 경우, 혹은 기타 다양한 이유로 인공호흡을 할 수 없는 경우, 가슴 압박만 하더라도 아무것도 하지 않을 때보다 심정지 환자의 생존율을 높일 수 있습니다.
- 의수에 의한 심정지의 흔한 원인은 저산소 혈증이며, 인공호흡이 예후 향상에 도움이 됩니다. 일반인이 아닌 응급의료종사자는 표준심폐소생술을 시행하면서 전문기도기를 삽입하고 산소를 투여해야 합니다.



나) 심폐소생술에서의 어린이와 성인의 구분

- » 만 8세 이상의 어린이에서는 성인에게 적용하는 심폐소생술을 적용합니다.
- » 만 8세 미만의 소아의 체구가 커서 성인과 구분이 어려울 때는 구조자의 판단에 따라 소아 또는 성인 심폐소생술을 적용합니다.
- » 심폐소생술에서의 나이의 정의는 다음과 같습니다.
 - ① 신생아: 출산한 때로부터 4주까지
 - ② 영아: 만 1세 미만의 아기(표준 가슴압박 깊이 4cm)
 - ③ 소아: 만 1세부터 만 8세 미만까지(표준 가슴압박 깊이 4~5cm)
 - ④ 성인: 만 8세부터(표준 가슴압박 깊이 5cm)



소아(만 8세미만) 심정지 환자의 가슴압박
(2020년 한국심폐소생술가이드라인)

- 소아와 성인 사이에는 심장정지 원인에 차이가 있으며 체구가 다르므로 심폐소생술 방법에도 약간의 차이가 있습니다.
- 심폐소생술 가이드라인에서 나이의 구분은 심정지 현장에서 적용 가능성과 교육의 수월성을 고려하여 정해진 것이며 비록 구조자가 환자의 나이를 잘못 판단하였더라도 환자에게 중대한 위해를 초래하지는 않습니다.

2. 야외활동 안전사고 예방 및 응급처치 수칙

- » 야외활동 중에는 다양한 안전사고가 발생할 수 있고 어린이들은 익숙하지 않은 상황에서 예측하기 어려운 행동을 하기 쉬우므로 활동 전에 어린이들에게 사고를 예방하기 위한 안전수칙을 교육해야 합니다.
- » 활동 지역의 위험 요소를 활동 전에 미리 파악하여 제거하고, 활동 진행 중에도 수시로 주변 환경을 점검하고 발견되는 위험 요소를 차단합니다.
- » 주로 발생하는 손상은 넘어짐, 부딪힘, 베임 등에 의한 찰과상, 타박상 등의 경증 연조직 손상과 염좌 및 사지 골절 등 근골격계 손상이 흔합니다. 그러나 간혹 높은 곳에서 떨어져서 발생하는 추락 손상의 경우 두부 손상이나 내출혈 등으로 심각한 응급 상황이 초래되기도 합니다.

가. 사고 발생 시 행동 지침

1) 어린이 주의사항

- » 어린이들에게 현장에 접근하지 말아야 합니다.
- » 선생님과 부모님으로부터 멀리 떨어지면 안됩니다.

2) 동행 교사 주의사항

- » 당황하지 말고 전체 상황을 신속히 파악하고 조치합니다.
- » 현장 안전을 확인한 후, 위험하다고 판단되는 경우에는 모두 대피하도록 하고, 현장이 안전하더라도 사고 현장 주변으로의 어린이 접근을 통제합니다.
- » 응급조치를 하고 119에 신고 또는 즉시 병원으로 옮기도록 합니다.
- » 응급처치 시행에 어려움이 있으면 119에 신고하여 응급의료 상담원의 지시에 따릅니다.
- » 환자가 여러 명 발생하였으면 긴급한 환자부터 응급처치합니다.
- » 환자의 의식 및 호흡이 없다면 즉시 심폐소생술을 실시합니다.
- » 소속 기관 및 관계 기관에 연락하고 사고 일시와 장소를 기록합니다.
- » 보호자에게 연락하여 사고 내용, 부상 수준 등 상황을 설명합니다.
- » 119구급대원 또는 환자의 보호자 도착 전까지 현장을 이탈하지 않습니다.

✓ 119 신고 요령

- » 부상자의 위치를 정확히 알립니다.
- » 무슨 일이 일어났는지 정확하게 설명하고, 부상자의 수와 상태를 구체적으로 알립니다.
- » 주변에 위험 요소가 있다면 알립니다.
- » 구급차가 도착하기 전까지 부상자의 응급처치에 대한 도움을 받을 수 있으므로 되도록 전화를 끊지 않고 연락을 유지합니다.

- 공원 내 특정 장소, 건물 이름 등을 구체적으로 알립니다.
- 화재, 구조물 붕괴 위험성, 독성 가스, 폭발 위험성, 교통사고 위험성 등

나. 손상 유형별 응급처치 수칙

1) 염좌 또는 골절 의심

- » 다친 부위를 움직이지 않게 하고 높게 올려줍니다.
- » 부종이 발생하면 냉찜질을 해줍니다.
- » 고정은 부상 부위의 위, 아래 관절을 포함하여 가능하면 길게 고정합니다.
- » 골절이 발생하면 골절 부위를 움직이다가 다친 뼈 주변 혈관이나 신경을 건드리면 추가 손상이 발생할 수 있으므로 움직이지 않도록 조심해야 합니다.

- 직접 얼음이 닿지 않도록 수건 등으로 감싸서 사용합니다.

2) 사지 외상

- » 손상 부위를 함부로 움직이지 않습니다.
- » 다친 곳은 되도록 심장보다 높이 올려줍니다.
- » 부종: 얼음 주머니 등을 이용하여 냉찜질을 해주고 붕대를 사용하여 압박을 시도할 수 있습니다.
- » 출혈: 출혈이 있으면 상처 부위에 헝겊 등을 대고 출혈이 멎을 때까지 세게 누르고 출혈 부위를 심장보다 높게 위치시켜 줍니다.
- » 열린 상처: 열린 상처가 있으면 손을 씻고 상처 부위를 깨끗이 씻어낸 후 소독하고 드레싱 합니다. 소독이 필요할 때는 상처의 중심에서 바깥쪽으로 소독합니다.
- » 이물질: 얇게 박힌 경우는 제거하고, 깊게 박힌 경우는 출혈이나 손상이 심해질 수 있으므로 되도록 제거하지 않고 움직이지 않도록 고정한 후 병원으로 이송합니다.

- 포비돈 요오드(아이오딘), 과산화수소수 등을 사용할 수 있고, 나선을 그리며 상처의 중심부에서 바깥쪽으로 부드럽게 닦아내듯 소독합니다.

3) 화상

- » 흐르는 차가운 물로 15분 이상 화상 부위를 식힙니다.
- » 화상 부위가 부었을 때 옷이 낄 가능성이 있으면 미리 제거합니다.
- » 화상 부위는 깨끗한 멸균 처리된 거즈로 덮어주고, 물집은 터뜨리지 않습니다.
- » 화상 부위에 물집이 잡히거나 심한 통증을 호소하는 경우, 또는 뼈나 힘줄이 보일 정도로 깊은 화상을 입은 경우에는 2도 이상의 화상이 의심되므로 119에 연락하여 신속하게 병원으로 이송합니다.
- » 얼굴 등 연약한 부위에 화상이 발생했을 때도 119에 연락하여 신속하게 병원으로 이송합니다.

- 심부에 남아있는 열로 화상이 진행할 수 있어 충분히 냉각해 줍니다. 깨끗한 물이 없으면 수돗물을 틀어놓고 화상 입은 피부 부위에 물을 지속적으로 흘려보내는 것도 좋은 방법입니다. 그러나, 저체온증이 의심 될 때는 중단합니다.
- 물집은 자연적인 보호막 역할을 하므로 억지로 터뜨리지 않습니다.

4) 추락 손상

- » 즉시 119에 신고합니다.
- » 현장 주변이 위험한 상황이 아니라면 2차 손상을 막기 위해 환자가 움직이지 않게 합니다. 특히 목, 머리를 움직이지 않도록 주의합니다.
- » 사지에 외상이 발생하였으면 해당 부위에 대해 응급처치합니다.

- 목 부위의 움직임을 추가로 가하는 경우, 경추(목뼈) 손상이 심해질 수 있습니다.

다. 기본 심폐소생술(일반인 구조자)

- » 의식이 없다면 어깨를 흔들고 두드리며 깨워봅니다.
- » 깨워도 반응이 없는 경우 즉시 주변 사람들에게 119에 신고하고 자동 심장충격기를 가져오도록 요청한 후 119 구급상황요원의 조언에 따릅니다.
- » 환자의 호흡이 정상이라면 관찰하면서 119 구급대를 기다립니다.
- » 환자의 호흡이 없거나 비정상적이라면 심폐소생술을 시작합니다.
- » 119 도착이나 자동심장충격기 도착까지 심폐소생술을 지속합니다.
- » 자동심장충격기를 사용할 수 있으면 음성지시에 따라서 제세동을 합니다.
- » 제세동이 필요하지 않거나 제세동을 한 직후에는 2분 동안 심폐소생술을 시행한 다음 자동심장충격기로 다시 심장 리듬을 분석합니다.
- » 119 구급대가 도착하거나 환자가 움직이거나 호흡이 정상화될 때까지 심폐소생술을 멈추지 않아야 합니다.
- » 심폐소생술은 일반인 구조자의 숙련도나 의지에 따라 가슴압박과 인공 호흡을 함께 하는 표준심폐소생술을 기본으로 하되 인공호흡이 불가능하다면 가슴압박소생술만 제공하는 것도 가능합니다.

- 기본 심폐소생술 방법에 대한 상세한 내용은 11페이지를 참조 바랍니다.

3. 환경손상 예방을 위한 예방 및 응급처치수칙

가. 온열질환

- » 온열질환은 뜨거운 환경에 장시간 노출될 때 열로 발생하는 급성질환입니다.
- » 고온의 환경에 오랫동안 노출되어 체온이 올라가면, 우리 몸에서는 피부로 보내지는 혈액량을 늘려 열기를 발산하고 땀을 흘려 체온을 낮추려고 하며, 이 과정에서 많은 양의 수분과 염분을 잃게 되어, 지속 시 온열질환이 발생하게 됩니다.
- » 비교적 가벼운 일사병부터 사망에 이를 수 있는 열사병까지 중증도는 다양합니다.

1) 일사병

- » 고온 환경에서 땀을 많이 흘리고 두통, 구토 등의 증상이 나타나는 질환으로, 고온의 환경에서 수분 및 염분 보충이 원활하지 않아 수분이 감소하면 발생하게 됩니다.
- » 심부체온이 37도에서 40도 사이로 상승하게 됩니다.
- » 중추신경계에 이상(의식변화, 발작, 환각, 혼수 등)은 없습니다.
- » 증상 : 다량의 땀을 흘림, 시력장애, 기력 저하, 어지럼증, 두통, 오심, 구토, 실신, 근육경련, 빠른 맥박과 호흡.

2) 열사병

- » 고온 환경에서 체온조절중추가 기능을 못해 몸속의 열을 발산하지 못하는 질환으로, 일사병 발생 후 적절한 처치가 되지 않는 경우 발생하게 됩니다.
- » 심부체온이 40도 이상 상승하게 됩니다.
- » 중추신경계 이상(의식변화, 발작, 환각, 혼수 등)이 발생하며, 지속 시 장기가 손상되며 쇼크를 일으키며 사망할 수 있습니다.
- » 증상 : 땀이 나지 않음, 고열, 의식변화

3) 온열질환 예방 방법

- » 여름철에 외부 활동이 진행되는 경우 기온과 날씨를 확인합니다. 폭염 주의보나 폭염경보 등 폭염특보가 내려졌으면 야외활동을 자제합니다.
- » 야외활동을 하는 경우 정오부터 오후 4시까지의 활동을 피합니다. 활동 시 중간중간 그늘에서 충분한 휴식 시간을 가지고 수분을 섭취합니다.
- » 실내 활동 시 냉방시설을 활용하고, 냉방시설이 없는 경우 햇볕을 차단하고 맞바람이 불도록 충분한 환기를 합니다.

- 환경적 원인에 의한 여러 가지 손상 중에서 온열질환, 알레르기, 벌레 물림, 뱀물림 등을 다루고 있습니다.

- 시판하는 이온 음료도 좋은 전해질 공급원이 됩니다.

가) 어린이 주의사항

- » 물이나 이온 음료를 충분히 마셔야 합니다.
- » 활동 중 현기증, 메스꺼움, 두통, 근육경련 등의 증세가 있는 경우 즉시 선생님과 부모님에게 알려야 합니다.

나) 동행 교사 주의사항

- » 이동 시 어린이가 혼자 차 안에 남아있지 않도록 인원 점검을 철저히 합니다.
- * 화상 대비 : 햇빛에 장시간 노출된 금속성의 기구는 화상을 유발할 수 있어 주의하고, 선크림을 발라 햇빛에 의한 화상을 예방합니다.



더운 날씨, 야외활동을 할 때 땀을 많이 흘리고 어지러우면 물을 마시고 시원한 그늘로 이동해요.

4) 온열질환 응급처치법

가) 의식이 명료한 경우 (일사병)

- » 시원한 장소(그늘과 바람이 부는 장소)로 이동합니다.
- » 옷을 벗기고 몸을 시원하게 합니다.
- » 충분한 수분 섭취(물, 이온 음료 등)를 합니다.
- » 위 처치에도 증상 지속 시 119 구급대를 요청합니다.

나) 의식이 없거나 의사소통이 어려울 정도로 처지는 경우 (열사병)

- » 우선 119 구급대를 요청합니다.
- » 시원한 장소(그늘과 바람이 부는 장소)로 이동합니다.
- » 옷을 벗기고 피부에 물을 뿌리고 부채질합니다. 얼음 등 차가운 것이 있다면 목, 겨드랑이, 허벅지 안쪽에 대줍니다.
- » 의식이 없는 경우 강제로 입에 물이나 음료를 흘려 넣지 않습니다.

- 물을 뿌리고 부채질하는 것만으로도 증발을 통해 빠르게 체온을 떨어뜨릴 수 있습니다. 차가운 물을 뿌리기 보다는 미지근한 물을 뿌려야 피부의 혈관 수축이 줄어들고, 효과적입니다.

나. 음식 알레르기

- » 음식 알레르기란 몸의 면역체계가 음식 내 단백질 성분과 반응하여 다양한 증상을 일으키는 면역 과민반응 현상입니다.
- » 개인의 면역 특성에 따라서 발생하기 때문에 집단으로 증상이 발생하지는 않으며, 집단으로 발생할 때는 알레르기보다는 식중독 등 다른 질환을 고려해야 합니다.

1) 증상

- » 가벼운 반응: 코막힘, 콧물, 기침(재채기), 입과 귀가 가려움, 입술 부종, 피부 붉어짐, 가려움증, 두드러기, 부종, 결막 충혈
- » 중등도/중증 반응(아나필락시스 반응): 목 불편감, 목소리 변화, 호흡 곤란, 쌉쌉거림, 발작적 기침, 혀 부종, 구역, 구토, 복통, 설사, 가슴 통증, 어지러움, 발한, 창백, 청색증, 쓰러짐, 저혈압
- » 대부분 음식 섭취 후 수 시간 내 증상이 나타나지만, 하루 이상 걸리는 때도 있습니다.

2) 음식 알레르기 예방 방법

가) 어린이의 준비

- » 음식 알레르기가 있는 어린이에게 다른 친구들이 알레르기 음식을 먹어보라며 장난치지 않습니다.
- * 알레르기 원재료 표시 대상(식품의약품안전처) : ① 난류 ② 우유 ③ 메밀 ④ 땅콩 ⑤ 대두 ⑥ 밀 ⑦ 고등어 ⑧ 계 ⑨ 새우 ⑩ 돼지고기 ⑪ 복숭아 ⑫ 토마토 ⑬ 아황산류 ⑭ 호두 ⑮ 닭고기 ⑯ 쇠고기 ⑰ 오징어 ⑱ 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)

나) 동행 교사의 준비

- » 인솔자는 체험학습 전 특정 음식에 대한 알레르기가 있는 어린이를 미리 파악합니다.
- * 식사가 제공되는 체험학습의 경우 식사 전 사용 재료를 알 수 있도록 하여, 해당 재료에 알레르기가 있는 어린이가 직접 음식을 제외하고 먹을 수 있도록 안내합니다.
- » 이 식품들을 원재료를 사용했거나 제조 과정에서 혼입될 가능성이 있는 경우 그 재료를 표시하도록 법적으로 의무화하고 있습니다.

3) 음식 알레르기 응급처치법

- » 음식을 먹은 뒤 알레르기 증상이 있는 경우 즉시 주변 친구들과 인솔자에게 알립니다.
 - 중등도/중증 반응이 있는 경우 즉시 119 구급대를 요청합니다.
 - 알레르기 증상이 나타난 어린이가 편안한 자세를 취할 수 있도록 합니다.
 - 이미 응급알레르기 주사(자가주사용 에피네프린)를 가지고 있다면 자기가 주사를 할 수 있도록 도와줍니다.

- 우유, 달걀, 땅콩, 갑각류, 생선, 견과류, 밀, 콩 이 8가지가 알레르기를 유발하는 비율이 전체 식품의 90%를 차지하며, 이외에도 복숭아, 사과, 딸기, 포도 등의 과일류와 땅콩, 잣, 아몬드 등 견과류, 밤, 옥수수에 알레르기 반응을 일으키기도 합니다.



- 호흡이 불편한 경우 앉아 있는 자세를 유지하고 혈압이 떨어지는 경우 누워있는 자세를 유지합니다. 다리를 높여 주변 추가로 도움이 됩니다.

다. 일반 알레르기

- » 야외에서는 다양한 원인으로 알레르기가 나타날 수 있습니다.
- » 천식이 있는 어린이가 꽃가루에 노출되거나 다른 알레르기 유발 물질에 노출되면 호흡곤란 등 급성 알레르기 증상이 나타날 수 있습니다.
- » 어린이가 갑자기 콧물, 기침, 두드러기 등과 같은 증상을 보이거나 호흡 곤란을 보이면 알레르기력을 확인하고 알레르기를 의심하고 조치해야 합니다.

1) 어린이의 준비

- » 기존에 알레르기가 있다면, 선생님께 바로 알려야 합니다.

2) 동행 교사의 준비

- » 증상이 심할 경우 119에 연락하여 신속하게 병원으로 이송합니다.
- » 기존에 알레르기력이 있는 어린이라면 평소 먹는 약이 있는지 확인합니다.

- 체험활동 전에 기존 복용 중인 약 또는 천식 환아의 경우 흡입제는 확인하여 지참하도록 합니다.

라. 벌레 물림

1) 흔하게 노출되는 벌레의 종류

- » 모기: 주로 풀숲에 서식하며, 물릴 시 가려움증을 유발하고 긁으면 2차 피부 손상 및 염증을 유발할 수 있습니다.
- » 벌: 쏘일 때 날카로운 통증이 느껴지며, 이후 물린 부위가 화끈거리며 부을 수 있습니다. 전신반응인 아나필락시스 반응이 유발되는 경우 즉각적으로 처치하지 않으면 생명이 위독할 수 있습니다.
- » 진드기: 풀숲에 서식하며, 야생동물의 털에 달라붙어 있을 수도 있습니다. 몸에 달라붙어 고정 후 흡혈합니다.
- » 벼룩: 야생동물에 서식하며 동물을 만진 후 피부에 작고 붉은 물집이 생기면서 가렵게 됩니다.

- 진드기를 발견한 경우, 몸에 박혀 있다면 핀셋으로 잡아당겨서 제거해야 합니다. 바이러스를 옮길 수 있으므로 발열 등의 증상이 있으면 즉시 병원에 방문하도록 하고, 이런 증상은 1주일 후에도 발생할 수 있습니다.

2) 벌레 물림의 증상

- » 벌레에 물린 후 물린 부위의 간지러움과 붓기 및 통증이 발생할 수 있습니다.
- » 가려움증 이외에 전신 증상(발열, 두통, 현기증, 관절 및 근육통, 구토 등)이 나타나는 경우, 즉시 병원에 방문해야 합니다.

3) 벌레 물림 예방 방법

가) 어린이의 준비

- » 밝은색의 긴 옷을 입고 양말을 착용해야 합니다

나) 동행 교사의 준비

- » 취침 시설에는 방충망이나 모기장을 설치합니다.
- » 진드기 위험이 높은 4~11월에는 풀밭이나 들판에서 활동 시에는 긴 상의와 긴 바지, 양말을 착용하며 바닥에 앉을 때에는 돛자리를 사용합니다.
- » 야외활동 전 얼굴을 제외한 노출되는 피부에는 방충제 또는 모기기피제 뿌립니다. 신발과 가방에도 방충제를 뿌려 벌레가 달라붙는 것을 막습니다.
- » 밝은색의 옷을 입습니다. 밝은색의 옷은 벌레가 붙으면 쉽게 발견하여 털어낼 수 있습니다.

4) 벌레에 물렸을 때 응급처치법

- » 물린 부위를 차가운 물로 씻어냅니다.
- » 물린 부위를 10분간 얼음팩으로 찜질합니다.
- » 몰파스나 벌레물림 연고를 바를 수 있습니다.
- » 가렵다고 긁거나 침을 바르지 않습니다.
- » 물린 부분이 심하게 부을 경우, 물린 부위를 심장보다 높게 유지합니다.
- » 전신 증상 발생 시에는 (전신발진 및 부종, 어지러움, 쓰러짐, 호흡곤란, 구토 등)이 있는 경우 즉시 119 구급대를 요청합니다.

5) 벌에 쏘인 경우

- » 벌에 쏘인 경우 즉시 주변 친구들과 인솔자에게 알립니다.
- » 환자를 벌이 없는 안전한 곳으로 옮깁니다.
- » 알레르기 반응이 나타날 수 있으므로 의심 증상이 보이면 119에 연락하여 신속하게 병원으로 이송합니다.
- » 쏘인 부위에 벌침이 남아있으면 바늘, 칼 등으로 제거할 수 있습니다. 다른 기구가 없을 경우 플라스틱 카드로 긁어서 제거하는 것도 가능합니다.
- » 통증이 있거나 붓는 경우 얼음이나 차가운 것을 대어 냉찜질해주고 높게 올려줍니다.
- » 2차 감염 방지를 위해 긁지 않도록 합니다.



- 얼음팩 사용 시 직접 피부에 닿지 않게 수건 등으로 겹면을 감싸 사용해야 합니다.

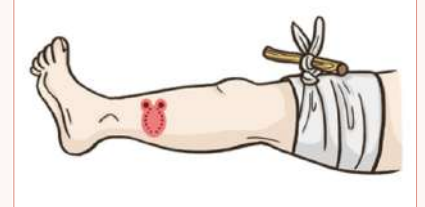


마. 뱀물림

1) 동행 교사의 준비

- » 뱀의 머리가 삼각형이고 상처 부위에 2개의 이빨 자국이 있다면 독사로 판단합니다.
- » 환자를 뱀이 없는 안전한 곳으로 옮기고 119에 연락하여 신속하게 병원으로 이송합니다.
- » 손상 부위를 심장보다 낮게 위치시키고 물린지 15분 이내면 물린 부위의 10cm 위쪽을 붕대 또는 폭 2cm 이상의 넓은 끈이나 천 등으로 손가락 하나가 통과하도록 묶습니다.
- » 입으로 독을 빨아내거나 상처 부위를 절개하는 것은 손상이 커질 수 있으므로 하지 않고 119에 연락한 후 응급의료 상담원의 지시에 따릅니다.

- 뱀물림의 경우에 뱀 종류를 확인하려고 반드시 뱀을 잡으려고 할 필요는 없습니다. 보호자와 어린이 모두 안전하게 뱀이 없는 곳으로 대피합니다.



- 심장에 가까운 쪽을 묶어줍니다. 순환에 방해가 될 정도로 동맥 압력을 초과하도록 강하게 묶을 필요는 없고, 손가락 하나가 통과할 정도로 묶어 줍니다.

4. 이동중 운수사고 예방 및 응급처치

- » 체험활동의 시작과 끝이 운송수단으로 이루어져 있습니다.
- » 단체로 이동하는 상황을 자주 겪어보지 못한 어린이들의 예측하기 어려운 행동으로 다양한 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- » 이동 수단별로 예측되는 위험 요소를 인솔자가 파악하고 어린이들에게 안전수칙을 교육해야 합니다.

가. 도보

- » 체험활동 기획 단계에서 되도록 목적지까지 차량으로 이동하여 도보 이동은 줄이고, 차도나 횡단보도가 포함된 경로를 피하는 것이 바람직합니다.

1) 인도 통행 시

가) 어린이의 준비

- » 유아의 경우는 보호자의 손을 잡고 걷습니다.
- » 되도록 인도가 구분되어 있는 경로를 선택하고, 인도의 안쪽을 이용하여 걷도록 합니다.
- » 인도와 차도의 구분이 되어 있지 않은 도로에서는 차도와 멀리 떨어져 다니도록 합니다.
- » 이동 중에는 차도에 가까이 다가가지 않도록 주의시킵니다. 특히 인도와 차도 구분이 없는 도로가 있다면 더 주의가 필요합니다.
- » 좁은 길에서 차량이 지나가면 잠시 멈추고 기다립니다.
- » 운전자가 있거나 시동이 걸려있는 차량 주변에서는 더욱 조심해서 걷습니다.
- » 비탈길에 주·정차되어 있는 차량 앞뒤로 다니지 않습니다.
- » 공사장 주변 길은 위험하므로 되도록 다른 길을 이용합니다.
- » 주변 환경에 집중을 잃지 않도록 주의가 필요합니다. 걸어서 이동할 때는 휴대전화를 사용하지 않으며, 이어폰을 착용하지 않습니다.
- » 걸으면서 장난하지 않습니다.
- » 길을 다니면서 뛰거나 갑자기 방향을 바꾸지 않습니다.

나) 동행 교사의 준비

- » 어린이집이나 초등학교 저학년을 대상으로 한 체험활동에 도보 이동이 포함되는 경우, 동영상 등을 이용해서 미리 도보 통행에 대한 교육을 추가로 실시하는 것이 좋습니다.



2) 횡단보도

가) 어린이의 준비

- » 횡단보도를 건너는 방법에 대한 교육이 필요하고, 되도록 인솔자와 붙어서 건너도록 합니다. 한 손을 들고 건너고 인솔자가 곁에 있다면 손을 잡고 걸어갑니다.
- » 횡단보도에서 신호등의 색에 따라 건너야 함을 교육하고, 신호가 바뀐 직후나 시간이 얼마 남지 않았을 때가 위험함을 강조합니다. 횡단보도에서 신호등이 초록불로 바뀌더라도 주변의 차가 멈추었는지 왼쪽과 오른쪽을 모두 확인합니다. 초록불이 깜박일 때나, 신호등의 시간이 얼마 남지 않았을 때는 무리해서 건너지 말고 다음 신호를 기다립니다.
- » 신호등이 없는 횡단보도에서는 차량이 완전히 멈추었거나 운전자의 손 신호가 있을 때 건넙니다.
- » 횡단보도 안의 오른쪽으로 걷고, 장난하지 않도록 합니다. 횡단보도가 아닌 곳을 무단으로 건너면 안 됩니다.

나) 동행 교사의 준비

- » 어린이집이나 초등학교 저학년을 대상으로 한 체험활동에 도보 이동이 포함되는 경우, 동영상 등을 이용해서 미리 도보 통행에 대한 교육을 추가로 실시하는 것이 좋습니다.

나. 차량

1) 운행 전후

가) 어린이의 준비

- » 차도에서 탑승하는 경우 버스를 기다릴 때는 인도에서 차도로 미리 내려와 있지 않게 주의시킵니다. 버스가 도착한 다음 차례로 승차합니다.
- » 차를 탈 때 차례를 지켜 천천히 타고, 차에서 내릴 때는 좌우를 살피고 천천히 내립니다.
- » 차에 타고 내릴 때는 긴 치마나 끈 달린 옷, 가방 등이 차 문에 끼어 끌려갈 수 있으므로 주의합니다.

나) 동행 교사의 준비

- » 동선을 잘 계획하여 되도록 시설의 지정된 주차장 또는 차도와 분리된 공간에서 어린이들이 승하차하는 것이 좋습니다.
- » 차가 출발하기 전에 안전벨트를 반드시 착용하고 안전벨트에 이상이 없는지 확인합니다.
- » 안전벨트는 꼬이지 않게, 몸에 붙게 착용하고 등받이 상태를 조절합니다.

- 꼬인 채로 안전벨트를 착용하거나 잘못된 위치에 착용하면 오히려 다칠 수 있습니다.



**정차되어 있는 차 주변, 특히 바로 앞이나 뒤에서
장난치거나 서있으면 안 돼요.**

2) 운행 중

가) 어린이의 준비

- » 차 안에서는 정해진 좌석에 앉아 안전벨트를 계속 착용해야 하며 돌아다니지 않습니다.
- » 차 안에서는 자리를 이동하거나 장난을 치지 않도록 하고, 창밖으로 손, 머리를 내밀거나 쓰레기를 버리면 안 됩니다

나) 동행 교사의 준비

- » 차 안에서는 정해진 좌석에 앉도록 지도해야 하며, 사고가 발생하거나 하였을 때 인원 파악에도 용이합니다.

3) 사고 발생

- » 사고가 발생하면 선생님이나 보호자의 안내대로 사고 차량 밖으로 나온 뒤에 차와 멀리 떨어진 안전한 곳으로 이동합니다.
- » 차량 내부에서 대피 순서를 지정하고, 앞좌석부터 순서대로 나오는 등의 규칙을 미리 정하고 숙지합니다.
- » 문으로 내리기 어려운 경우 인솔자/보호자가 비상탈출용 망치를 이용하여 창문을 깨고 탈출합니다.



다. 기차/지하철

1) 승강장에서

가) 어린이의 준비

- » 역에서 승강장으로 이동하는 에스컬레이터를 이용할 때에는 손잡이를 잡고 탑니다.

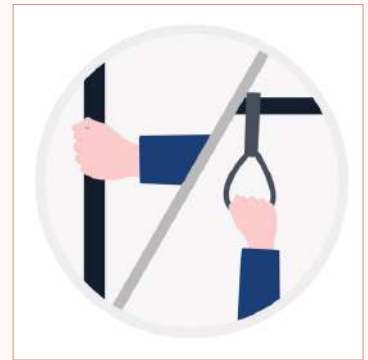


- » 올바른 플랫폼과 좌석 위치를 확인하여 미리 여유를 두고 탑승할 수 있게 합니다.
- » 사고가 나거나 선로로 떨어질 수 있으므로 승강장에서는 장난하지 않습니다.
- » 승강장에서 열차를 기다릴 때는 추락이나 열차와의 충돌을 예방하기 위해 반드시 노란 안전선에서 한 걸음 이상 떨어져 기다렸다가 열차가 완전히 정차한 후 승차합니다.
- » 반대선 선로 쪽으로는 절대로 건너지 말고, 선로 변에 머무르지 않습니다.
- » 승강장에 열차가 들어올 때는 안내방송에 따라 행동합니다.
- » 지하철 문이 열리면 열차 안의 승객들이 내리도록 문의 양쪽 가장 자리에서 서서 기다린 후 차례대로 열차에 타도록 합니다.



- » 지하철 안에서는 의자에 착석하고 서서 이용하는 경우에는 반드시 안전바나 손잡이를 잡도록 합니다

- 에스컬레이터를 이용할 때에는 갑자기 균형을 잃거나 주변 사람에 부딪혀 넘어져서 다치는 사고가 종종 일어납니다. 뿐만 아니라 에스컬레이터가 갑자기 멈추거나 역주행하는 사고도 발생할 수 있기 때문에 반드시 손잡이를 잡고 이용하도록 합니다.



나) 동행 교사의 준비

- » 지하철의 경우, 출퇴근 시간 등 사람이 물리는 시간은 어린이들이 한꺼번에 타고 내리기 어려울 수 있어 이동 시간을 잘 선택해야 합니다.

2) 사고 발생

- » 사고 발생 시 기관사와 승무원의 안내방송에 따라 대피합니다.
- » 대피가 필요할 때는 승강문 비상 열림 장치를 이용해 대피하고, 승강문이 열리지 않으면 비상용 망치를 이용하여 창문을 깨고 탈출합니다.
- » 사고 발생으로 대피 후에는 안전한 장소에서 구급차, 대체 열차, 버스 등 다른 교통수단을 기다립니다.

라. 선박

1) 항해 전후

가) 어린이의 준비

- » 함께 탄 선생님 또는 보호자와 함께 구명보트, 구명조끼, 비상벨, 비상구가 있는 위치를 확인합니다.
- » 선내에 비치된 구명조끼 착용법을 알아둡니다. 다리 쪽 끈을 고정하는 방식에 특히 주의해야 합니다.
- » 부두에 선박이 완전히 정지한 후 승무원의 안내에 따라 질서를 지키며 타고 내립니다.

나) 동행 교사의 준비

- » 만일의 사고에 대비하여 휴대전화와 예비 배터리를 사전에 준비해 둡니다.

2) 항해 중

가) 어린이 주의사항

- » 승객 출입금지표로 표기된 장소에는 출입하지 않습니다.
- » 비상 상황이 아닌 경우 소화기, 구명 기구 등은 함부로 만지지 않습니다.
- » 계단을 이용할 때는 반드시 난간을 잡고 이동합니다.
- » 비나 눈이 오거나 바람이 심하게 불 때는 위험하므로 갑판으로 나가지 않습니다.

나) 동행 교사 주의사항

- » 선박의 구조물은 단단한 재질로 되어 있어 넘어지면 크게 다칠 수 있으므로 뛰지 않도록 교육합니다.

3) 사고 발생

- » 승무원의 안내에 따라 최대한 질서를 유지하면서 구명조끼를 착용하고 구조를 기다립니다.
- » 배에서 '쿵' 소리나 폭발음이 들리고 배에 충격이 가해지는 등 사고 발생 시 가능한 선실에서 벗어나 탈출이 쉬운 갑판으로 피합니다.
- » 출입문, 비상구가 열리지 않을 때는 가까운 곳에 비치된 도끼를 이용해 창문을 깨고 탈출합니다.
- » 선체가 한쪽으로 기울 때는 반대 방향의 높은 쪽으로 대피합니다.
- » 배가 침몰 시 성급하게 바다로 뛰어들면 거대한 소용돌이가 일어나 주변을 빨아들여 깊은 물 속에 잠길 수 있으므로 주의해야 합니다.
- » 체온 유지가 중요하므로 팔을 서로 끼고 다리를 당겨 올리고 머리를 세워 체온을 유지하도록 교육합니다.

마. 응급처치

- » 먼저 자신의 안전을 확인한 후 주변의 안전 여부를 파악합니다. 추가로 다른 사람들의 안전도 확인하세요.
- » 즉시 119에 연락하여 도움을 요청합니다. 사고 위치와 피해 상황에 대한 정보를 명확하게 전달해야 합니다.
- » 운수사고 응급 처치는 전문지식과 훈련이 필요한 부분이므로, 최대한 응급의료 전문가의 도움을 기다리는 것이 좋습니다.
- » 아래 내용은 일반적인 상황에 대한 기본적인 지침일 뿐, 실제 상황에 따라 적절한 응급조치가 달라질 수 있습니다.
- » 환자를 이동시키지 않는 것이 원칙이며, 척추나 머리에 손상이 발생한 경우 움직임이 발생하면 척수가 손상되어 마비를 유발할 수 있습니다.
- » 환자가 의식이 없거나 호흡, 맥박이 없다면 심폐소생술을 수행합니다. 가능한 경우, 응급상황에서 환자를 이동시키지 않고 의료 전문가의 도움을 기다립니다.
- » 환자가 의식이 있고, 단순 출혈일 경우 깨끗한 거즈 등을 통하여 지혈하고, 골절 또는 탈골이 의심되는 경우, 부상 부위를 고정시켜 주는 등의 조치를 취합니다.
- » 복부등에 이물질이 박혀있을 경우 임의로 제거하지 않습니다. 이물질을 제거하는 과정에서 추가적인 장기손상이나 출혈이 발생할 수 있습니다.

체크리스트

어린이 체험활동
손상예방을 위한
가이드라인

물놀이 체험활동 체크리스트

■ 프로그램명 :

■ 일 시 : 20 년 월 일 00:00 ~ 00:00

■ 체험 장소 :

■ 점검자 :

사전 점검

대분류	세 부 항 목	확인	미충족	미충족 점검 사항
시설 기본	1 시설 규모(계획 인원의 수용 여부)	☐	☐	☐ 해당없음
	2 시설 소재지 (이동에 적절한 장소)	☐	☐	☐ 해당없음
	3 방송 등 안내 시설 유무	☐	☐	☐ 해당없음
시설점검   	4 시설관리 주체	☐	☐	☐ 해당없음
	5 안전수칙 보유 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	6 안전관리자 수, 위치와 역할	☐	☐	☐ 해당없음
	7 풀별 수심/수위	☐	☐	☐ 해당없음
	8 위험구역 위험표지판 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	9 풀에 설치된 각종 난간, 계단 등의 고정상태	☐	☐	☐ 해당없음
	10 낮은 천정 및 계단 등에 충격보호대 설치 상태	☐	☐	☐ 해당없음
	11 안전시설 점검 일자와 기록	☐	☐	☐ 해당없음
	12 구명환, 구명로프 등 인명구조장비 비치 여부 및 수량, 장소	☐	☐	☐ 해당없음
	13 미끄럼 방지 시설 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	14 물놀이 안전수칙 게시 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	15 위급상황 발생시 비상연락망, 신속 수송 의료시설 위치 파악 및 숙지 (현지 소방서, 경찰서, 보건소, 병원 등)	☐	☐	☐ 해당없음
	16 위생 상태 - 화장, 세면장, 음수대 및 정수기 등	☐	☐	☐ 해당없음
	17 사고 발생시 상황 조치 지침 (조난신호 장비, 신호기 구비)	☐	☐	☐ 해당없음
	18 구급약품 준비 여부	☐	☐	☐ 해당없음
야외 (해수욕장)	19 배상책임보험 가입 여부, 적격업체 (수상레저사업) 여부 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	20 위험지역 표시 등 안내	☐	☐	☐ 해당없음
	21 감시탑 설치여부와 위치 (100-200m 이내 1개소)	☐	☐	☐ 해당없음
	22 다이빙 위험구역 표지판	☐	☐	☐ 해당없음
야외 (계곡)	23 날씨 및 안전경보 (소나기, 천둥, 번개, 심한 안개 중단)	☐	☐	☐ 해당없음
	24 조석간만의 차가 큰 서·남해안의 경우 만조·간조 시간	☐	☐	☐ 해당없음
	25 안전사고예방을 위한 플랜카드 및 안전선 설치 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	26 자동우량 경보장치 작동 여부	☐	☐	☐ 해당없음
사전 준비	27 사고위험 지역에 간이 구명장비 비치 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	28 사고위험 지역에 수영, 야영금지 경고 등 안전표지판 설치 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	29 익사사고 위험구역 인명구조 체계 구축 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	30 여행자 안심공제 또는 여행자보험 가입	☐	☐	☐ 해당없음
사전 교육	31 인솔자 수	☐	☐	☐ 해당없음
	32 필요시 외부 안전요원 계약 (현장체험학습 동행, 인솔자 보조)	☐	☐	☐ 해당없음
	33 비상연락체계 (학생-학부모-인솔자)	☐	☐	☐ 해당없음
	34 보호자 설명 (안내문 또는 설명회)	☐	☐	☐ 해당없음
	35 이동 안전수칙 교육	☐	☐	☐ 해당없음
	36 물놀이 안전수칙 교육	☐	☐	☐ 해당없음
	37 물놀이 중 이상 발생시 대처요령	☐	☐	☐ 해당없음
	38 심폐소생술 교육	☐	☐	☐ 해당없음

체험학습 당일

대분류	세 부 항 목	확인	미충족	미충족 점검 사항
시설 점검	1 물의 깊이와 온도, 물 흐름 빠르기 확인(너울, 파도, 이안류 발생 시 중단)	☐	☐	☐ 해당없음
	2 현지 기상상태 (적정 수온 등) 파악 및 주기적 기상 변화 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	3 공기류트 등 물놀이 기구 작동 여부 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	4 안전장비 착용 여부 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	5 구조요원과 의무실 위치	☐	☐	☐ 해당없음
	6 참가 인원 파악 및 주기적 인원 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	7 인솔자, 외부 안전요원 배치 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	8 활동 전 건강상태 (이상 징후 학생 즉시 휴식), 건강요주 학생 파악	☐	☐	☐ 해당없음
야외 (계곡)	9 햇빛차단크림 적용 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	10 준비운동 시행 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	11 물놀이 안전수칙 (입수 시간 준수) 및 위험지역 활동 통제 교육	☐	☐	☐ 해당없음
	12 물놀이 중 이상 발생시 대처요령	☐	☐	☐ 해당없음
	13 응급상황 및 사고 발생시 행동지침	☐	☐	☐ 해당없음
	14 미끄럼틀 등 기구 안전 수칙 교육	☐	☐	☐ 해당없음

☑ 야외 체험활동 체크리스트 (낙상, 미끄러짐)

■ 프로그램명 :

■ 일 시 : 20 년 월 일 00:00 ~ 00:00

■ 체험 장소 :

■ 점검자 : ○○○○학교 ○○○

사전 점검

대분류	세 부 항 목	확인	미충족	미충족 점검 사항
체험활동 기획 	1 체험활동 형태에 맞는 인솔자, 안전관리자 확보	☐	☐	☐ 해당없음
	2 위급상황 발생시 비상연락망, 신속 수송 의료시설 위치 파악 및 숙지 (현지 소방서, 경찰서, 보건소, 병원 등)	☐	☐	☐ 해당없음
	3 학생, 보호자 비상연락체계 (학생-학부모-인솔자), 부재시 예비 연락망	☐	☐	☐ 해당없음
	4 응급상황 발생 시 신속한 응급처치를 위한 보호자 사전동의 취득	☐	☐	☐ 해당없음
	5 학생 병력 확인, 응급처치법 숙지, 인솔자간 정보공유 (알라지, 찬식, 당뇨 등)	☐	☐	☐ 해당없음
	6 체험활동 중 특별 보호 대상 확인 및 관리계획 수립, 지도교사 간 공유	☐	☐	☐ 해당없음
	7 날씨 및 안전경보 (소나기, 천둥, 번개, 심한 안개 중단)	☐	☐	☐ 해당없음
	8 사고 발생 시 대응 방법 및 보고 계획 수립	☐	☐	☐ 해당없음
	9 사고, 재난 발생시 응급처치 조치 계획 (대피로, 인솔교원 배치)	☐	☐	☐ 해당없음
	10 학생 인솔자 보험가입 결정, 영업배상책임보험 가입 여부 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	11 학생, 보호자 대상 일정, 준비사항(복장 등), 주의사항 전달	☐	☐	☐ 해당없음
시설   	12 시설 규모 (참여인원 수용확인)	☐	☐	☐ 해당없음
	13 시설 소재지 (이동 가능여부)	☐	☐	☐ 해당없음
	14 시설관리 주체 적격업체 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	15 안전관리자 수, 위치와 역할	☐	☐	☐ 해당없음
	16 안전수칙보유여부	☐	☐	☐ 해당없음
	17 안전시설 점검 일자와 기록	☐	☐	☐ 해당없음
	18 대피로, 비상탈출방법	☐	☐	☐ 해당없음
	19 위험구역 위험표지판 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	20 각종 난간, 계단 등의 고정상태	☐	☐	☐ 해당없음
	21 낮은 천정 및 계단 등에 충격보호대 설치 상태	☐	☐	☐ 해당없음
	22 미끄럼 방지 시설 여부	☐	☐	☐ 해당없음
숙박형 시설 사전 교육  	23 비상약품, 응급처치 장비 비치 여부, 수량 및 장소 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	24 배상책임보험 가입 여부	☐	☐	☐ 해당없음
	25 기구, 장비 관리 상태	☐	☐	☐ 해당없음
	26 날카로운 모서리, 튀어나온 부분 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	27 방 사이의 베란다가 넘어 다닐 정도로 설계되어 있지 않은지	☐	☐	☐ 해당없음
	28 유리 창문의 안전 잠금장치	☐	☐	☐ 해당없음
	29 규칙 준수의 중요성	☐	☐	☐ 해당없음
	30 비상상황 발생 대비 행동 요령	☐	☐	☐ 해당없음
	31 체험활동 시설 이용 안전사고 예방	☐	☐	☐ 해당없음
	32 공중시설 이용 예절	☐	☐	☐ 해당없음
	33 성범죄 예방교육	☐	☐	☐ 해당없음
	34 유해 물품 절대 휴대 금지	☐	☐	☐ 해당없음
	35 활동 편한 복장 및 이동이 불편한 복장에 대한 교육	☐	☐	☐ 해당없음
	36 운수사고 안전교육 (차량 비상탈출법, 안전벨트, 차량 내 소화기, 탈출용 망치 사용법 등)	☐	☐	☐ 해당없음
	37 대중교통 예절교육, 안전교육	☐	☐	☐ 해당없음
	38 휴게소 안전교육 (주차 차량 주의, 정차시간, 선생님 비상연락 교육 등)	☐	☐	☐ 해당없음

체험학습 당일

대분류	세 부 항 목	확인	미충족	미충족 점검 사항
안전체험 환경 	1 체험 장소 안전 확인 및 주변 위험요소 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	2 현지 기상상태 (소나기, 천둥, 번개, 심한 안개) 및 주기적 기상 변화 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	3 활동 전 건강상태 확인, 건강에 주의가 필요한 학생 파악	☐	☐	☐ 해당없음
	4 이동 장소마다 참여 인원 파악, 주기적 인원 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	5 업체의 안전교육 이행 요구 (학생인원 대비 적절 인솔자 수 배치)	☐	☐	☐ 해당없음
	6 학생 대상 안전교육 수행 (이동 시 학생 간 안전거리, 대피경로)	☐	☐	☐ 해당없음
	7 체험 및 관람시간(퇴장시간) 공지	☐	☐	☐ 해당없음
	8 대피로와 출입구의 인솔교원 배치	☐	☐	☐ 해당없음
	9 응급상황 및 사고 발생시 행동지침 교육	☐	☐	☐ 해당없음

[🔍] 체험학습 운수(차량)사고 예방 체크리스트

■ 프로그램명 :

■ 일 시 : 20 년 월 일 00:00 ~ 00:00

■ 체험장소 :

■ 점검자 :

사전 점검

대분류	세 부 항 목	확인	미충족	미충족 점검 사항
버스 출발 전 	1 차량등록원부, 종합보험가입 증명서, 정기검사필 관련 서류 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	2 운전자 적격심사 확인 (교통안전 정보조회 결과서 확인)	☐	☐	☐ 해당없음
	3 운전자 음주 여부 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	4 버스 체험학습 차량 안내 표지(앞, 뒤) 및 해당계약간별 운행기록증 부착	☐	☐	☐ 해당없음
	5 운행 일정을 협의 (경유지, 목적지, 휴게소 등) 경로, 운행시간 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	6 전체 좌석의 안전벨트가 정상적으로 조작 가능한지 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	7 개문 가능한 창문위치 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	8 내부 온도 조절 장치 정상적 작동 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	9 차량에서 기름 냄새 등 불쾌한 냄새가 나지 않는지 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	10 비상탈출용 망치, 소화기 등의 비치여부 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	11 버스 정원 내 탑승 및 참여 인원 전원 탑승 여부 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	12 안전띠 착용과 비상시 대피방법 등 설명	☐	☐	☐ 해당없음
	13 학생에게 운행 중 좌석을 이탈하지 않도록 교육	☐	☐	☐ 해당없음
	14 차량 운전자와 인솔책임자 연락처 메모 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	15 학생 및 학부모 비상 연락망 소지 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	16 비상약품 준비, 멀미하는 학생을 위한 봉투 준비 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	17 요보호 학생 명단 확인 (상비약, 자리 배치)	☐	☐	☐ 해당없음
버스운행 및 정차 전후 	18 휴게소 정차에 대하여 공지 (하차 전 출발시간 공지)	☐	☐	☐ 해당없음
	19 휴게소에서 지켜야 할 안전교육 실시: 반드시 좌우를 살피고 보행로를 이용하여 이동, 이동 및 주차, 후진차량 주의, 휴게소 내 뛰지 말 것 등	☐	☐	☐ 해당없음
	20 운전자가 반드시 규정된 운행속도 준수 안내	☐	☐	☐ 해당없음
역, 여객선 터미널, 공항 <도착 전> 	21 여행업자의 로고나 식별 가능한 크기 안내판을 이용하여 학생이 쉽게 여행업자 식별할 수 있도록 준비 및 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	22 이동수단, 운송편, 탑승시간, 탑승구, 출발시간, 소요 시간 등 필요한 정보 안내	☐	☐	☐ 해당없음
	23 탑승권, 객실 배정표 등을 이용하여 출발 인원을 확인	☐	☐	☐ 해당없음
역, 여객선 터미널, 공항 <도착 후> 	24 탑승권 발급 후 탑승구와 탑승 시간을 설명	☐	☐	☐ 해당없음
	25 탑승구로 안내하여 전원 탑승 여부 확인	☐	☐	☐ 해당없음
	26 비상시 대처요령 및 출입순서 교육 (안전벨트, 구명조끼 등)	☐	☐	☐ 해당없음

안전지도 고려사항

	세 부 내 용	확인
	1 대중교통 이용 시 사전 대중교통 예절교육과 안전교육을 실시	☐
	2 학생 안전벨트 착용 지도 및 확인, 휴게소 안전교육 실시, 운전자에 대한 과속운행, 음주운전, 신호위반, 대열운행, 끼어들기 금지 등 안전 운전 요청 및 확인	☐
	3 선박, 항공 이용 시 구명조끼 착용 및 비상 탈출 방법 교육 철저	☐
	4 이송 시 사전 모도를 편성을 권장하고, 가급적 혼잡시간대를 피하여 이동	☐
	5 계절, 지역특성, 교통상황 등을 고려한 일정을 수립하여 운행 일정 협의	☐
	6 무리한 운행일정 금지	☐
	7 2시간 운행 시 10분 이상 휴식시간 확보	☐
	8 운전자에게 학생을 대상으로 출발 전 안전교육 실시 요청: 유사시 차량 비상탈출법, 안전벨트 착용, 차량 내 소화기 위치, 탈출용 망치 사용법 등	☐

발 행: 2024.04.

발 행 인: 지영미(질병관리청장)

편 집 인: 최종균, 오진희, 배원초, 이정은, 황보나

발 행 처: 질병관리청 건강위해대응관 손상예방관리과

홈페이지: 국가손상정보포털 누리집(<https://www.kdca.go.kr/injury>)

주 소: (28161) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 125
고려대학교의생명공학연구원 2층 손상예방관리과

전화번호: 043-719-7419

팩 스: 043-219-2949

이 책은 질병관리청에 소유권이 있습니다. 질병관리청의 승인 없이
상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.

**어린이 체험활동
손상예방을 위한
가이드라인**



질병관리청